

MARIA INES PIRES GINER	
HD:	AOS
MEDICO:	Dr. Keffele
MEDICAMENTOS:	
IMC	
CIRCUNF. DE PESCOÇO	
PA:	
OXIMETRIA:	
23/11	P = 8.2 cmH ₂ O
21	Fuga = 7.7
	IAH = 1.0
22/12	P = 7.7
21	Fuga = 8.9
	IAH = 0.8
	Ajusto CPAP
21/03	P = 7.0
22	Fuga = 6.3
	M. de uso: 3h50'
22/09	P = 7.0
22	IAH = 1.5/h
	M. de uso: 3h58
22/10/24	P = 5.8 cmH ₂ O 6.9 mediano
	IAH = 2.9 e/h
	med. uso: 4h57'
	fuga: 9.7 l/m
09/11	Ajuste Air min (P = 4-10 cmH ₂ O) / <i>Natasha</i>
25	

LAUDO DA POLISSONOGRAFIA

NOME: Maria Inês Pires Giner

EXAME nº: 3561

SOLICITADO POR: Dr. Paulo César Ribeiro de Carvalho

DATA: 21/07/2017

IDADE: 52 anos

Comentários:

Exame iniciado às 22h45min e concluído às 06h34min. A latência para o sono foi de 6 minutos e a latência para o estágio REM, de 110 minutos. O tempo total de sono foi de 439,5 minutos (07h19min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 93,6%. A distribuição do sono registrado mostrou 16,3% de estágio 1, 39,2% de estágio 2, 18,5% de estágio 3 e 25,9% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 24 minutos em vigília, ocorreram 332 microdespertares (índice: 45,3/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 0/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 58/hora, sendo 27 apneia/hora e 31 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 58/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 97%, sendo a média de 89% e a mínima de 65%.

(*) TTS $\Rightarrow$ Tempo Total de Sono

TTR $\Rightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

Registraram-se aumentos acentuados dos índices de apneia/hipopneia (58/hora; normal até 4/hora; índice acentuado: acima de 30/hora) e de distúrbio respiratório (58/hora), dessaturações da oxi-hemoglobina, principalmente no decúbito dorsal e durante o estágio REM, arritmia cardíaca e despertares. As frequências cardíacas foram: mínima: 61; máxima: 83 bpm.

O ronco foi contínuo e baixo.

Ausência de respiração de Cheyne-Stokes.

A paciente adormeceu logo (latência para o sono: 6 min; normal até 30 min). A latência para o estágio REM foi normal (110 min; normal: 70 a 120 min). Apesar da eficiência do sono adequada (93,6%; normal: 85% ou acima), o sono foi fragmentado pelos microdespertares (índice: 45,3/hora; normal até 15/hora) – observei a intrusão de ritmo alfa nos estágios 2 e 3. Houve o aumento das porcentagens dos estágios 1 (16,3%; normal: 8-10%), 3 (18,5%; normal: 10-12%) e REM (25,9%; normal: 20%), e a redução do estágio 2 (39,2%; normal: 45-55%).

Ausência de movimentos periódicos de membros.

Escala de Sonolência de Epworth: 13 (sonolência diurna; normal até 9; máx: 24).

LAUDO DA POLISSONOGRAFIA

NOME: Maria Inês Pires Giner

EXAME nº: 3561-2 CPAP

SOLICITADO POR: Dr. Keffel Antônio Fernandes Pereira

DATA: 17/01/2018

IDADE: 53 anos

Comentários:

Exame iniciado às 22h14min e concluído às 06h16min. A latência para o sono foi de 14 minutos e a latência para o estágio REM, de 233 minutos. O tempo total de sono foi de 437,5 minutos (07h17min), com eficiência de sono (TTS/TTR)* de 90,6%. A distribuição do sono registrado mostrou 16,2% de estágio 1, 53,3% de estágio 2, 16% de estágio 3 e 14,5% de estágio REM. No período total de sono permaneceu 31 minutos em vigília, ocorreram 207 microdespertares (índice: 28,4/hora).

O índice de movimentos periódicos de membros foi de 2,1/hora.

O índice de apneia/hipopneia foi de 8,5/hora, sendo 3,8 apneia/hora e 4,7 hipopneia/hora. O índice de distúrbio respiratório (apneia+hipopneia+RERA) foi de 8,5/hora. A saturação basal da oxi-hemoglobina foi de 96%, sendo a média de 91% e a mínima de 76%.

(*) TTS $\Rightarrow$ Tempo Total de Sono TTR $\Rightarrow$ Tempo Total de Registro

CONCLUSÃO:

A paciente compareceu à Clínica Dr. Alberto Remesar para a adaptação ao aparelho CPAP, modo manual, sob a supervisão da fisioterapeuta Ana Cláudia de Matos (CREFITO: 29544 F). Ela usou a máscara nasal Mirage Activa standard (Resmed®). A pressão final recomendada foi de 7,8 cm H₂O.

Registraram-se aumentos leves dos índices de apneia/hipopneia (8,5/hora; normal até 4/hora; índice leve: 5 a 15/hora) e de distúrbio respiratório (8,5/hora), episódios de dessaturação da oxi-hemoglobina, principalmente durante o estágio REM, arritmia cardíaca e despertares. As frequências cardíacas foram: mínima: 51; máxima: 66 bpm.

Ausência de ronco com a pressão adequada e de respiração de Cheyne-Stokes.

A paciente adormeceu no tempo esperado (latência para o sono: 14 min; normal até 30 min). A latência para o estágio REM estava alongada (233 min; normal: 70 a 120 min). Apesar da eficiência do sono adequada (90,6%; normal: 85% ou acima), o sono foi fragmentado pelos microdespertares (índice: 28,4/hora; normal até 15/hora) – observei a intrusão de ritmo alfa nos estágios 2 e 3. Houve o aumento das porcentagens dos estágios 1 (16,2%; normal: 8-10%) e 3 (16%; normal: 10-12%), e a redução do estágio REM (14,5%; normal: 20%). A porcentagem do estágio 2 (53,3%; normal: 45-55%) permaneceu nos limites da normalidade.

O índice de movimentos periódicos de membros permaneceu no limite da normalidade (índice: 2,1/hora; índice normal até 4/hora). Observei também alguns movimentos de pernas após despertares.